



TOALETA, SUTURA (SCOS FIRE), PANSAMENTUL PLAGILOR

Definiție

- Plăgile sunt soluții de continuitate tegumentară și/sau a mucoaselor interesând în profunzime mai mult sau mai puțin țesutul celular subcutanat, mușchii și/sau pachetele vasculo-nervoase realizându-se o comunicare nemijlocită între țesuturi (amicrobine) și mediul înconjurător (populat bacteriologic).

■ Clasificarea plăgilor



■ În funcție de:



■ A. caracteristicile etiologice și patogenice ale agentului vulnerant



■ - plăgi înțepate

- - se produc prin pătrunderea unui agent vulnerant cu suprafață de impact mică (ascuțit);
- - caracteristic este traiectul subțire ce nu permite drenajul spontan;
- - interesează în profunzime tegumentul, țesutul celular subcutanat și mușchii



- plăgi tăiate

- - produse de obiecte tăioase;
- - margine netede cu absența pierderilor tegumentare și devitalizare minima;
- - necesită o atenție sporită, deoarece nu întotdeauna permit explorare completă a traiectului plăgii (*posibilă prezența unei plăgi penetrante!!!!*).



- plăgi contuze

- - produse prin zdrobire, pleznire sau smulgere tegumentară;
- - conține țesuturi zdrobite, împrejur țesuturi strivite și devitalizate și la periferie țesuturi în stupoare traumatică;
- - adiacent pot exista fracturi, leziuni de organe cavitare sau parenchimotoase.



B. caracterele anatomo-clinice ale leziunilor

- - plăgi superficiale;
- - plăgi profunde.

C. în raport cu timpul scurs de la producerea accidentului

- - plăgi recente (primele 6 ore)
- - plăgi neglijate (după 6-12 ore)

- Orice plagă se consideră contaminată din momentul producerii, microbii care invadează plaga încep să se dezvolte la scurt timp → plagă infectată. Din acest motiv cu cât tratamentul se plasează mai aproape de momentul producerii plăgii cu atât riscul ulterior al dezvoltării infecției este mai redus.
- În cazul plăgilor vechi examinate după depășirea „perioadei de aur” respectiv primele 6 ore, riscul dezvoltării infecției este cu atât mai mare cu cât s-a intervenit mai tardiv.

A. Stabilirea bilanțului lezional

- bilanțul lezional general în contextul unor posibile leziuni concomitente și/sau preexistente asociate;
- comorbidități asociate: TCC, sindroame comatoase, traumatisme toraco-abdominale cu leziuni ale organelor cavitare și/sau parenchimatoase, fracturi
- anatomia patologică a leziunii;
- localizarea topografică a plăgii;
- timpul scurs de la producerea accidentului.

B. Asistența chirurgicală de urgență

ÎN FAZA DE PRESPITAL (PRIMUL AJUTOR)

- - oprirea sângerărilor;
- - reducerea până la dispariție a riscului infecțios;
- - crearea condițiilor în care biologia vindecării decurge normal;
- - transferul rapid al bolnavului în condiții adecvate într-un serviciu chirurgical.

Aceste condiții se realizeaza prin:

■ **oprirea sângerărilor:**

- aplicare de garou, pense hemostatice, agenți hemostatici locali.

■ **decontaminarea tegumentelor adiacente plăgii:**

- spălarea mecanică cu apă și săpun a tegumentelor din jurul plăgilor (se îndepărtează noroiul, nisipul, uleiurile, sângele) reducând populația microbiană adiacentă plăgii;

- dezinfecția obține o decontaminare mai certă a tegumentelor din imediata vecinătate a plăgii (badijonări cu soluție antiseptică alcoolică: alcool iodat 1% sau 0,5%);

- pansament steril.

■ deconataminarea mâinilor



6 uscati cu prosop uscat



1 udati mainile



2 aplicati sapun si
spalati minim 15 sec



5
inchideti robinetul
folosind cotul



4 clatiti mainile



3 spalati dosul mainii,
spatii dintre degete
si unghiile

ÎN FAZA DE SPITAL

- **anestezie locală sau locoregională**

- **explorare**

- se badijonează tegumentul adiacent plăgii cu tinctură iodată și se izolează zona afectată cu material steril;
- se face bilanțul lezional.

- **debridare excizională**

- excizia țesuturilor devitalizate și contaminate - să fie eficientă și efectuată până se observă semne de vitalitate (colorație normală, sângerare difuză din marginile plăgii);
- se evacuează hematoamele;
- controlul hemostazei.

■ lavaj

- inițial se aseptizează zona adiacentă plăgii;
- se efectuează toaleta chimică a plăgii cu apa oxigenată, ulterior cu soluție de Betadină dinspre interiorul plăgii spre exterior.

■ sutura plăgilor

- instrumentar necesar: port ac, pensă anatomică, pensă chirurgicală, pensă Kocher (hemostază), pensă Pean (disecție), foarfec;
- se face pe planuri anatomice, pentru a desfiinșa „spașiile moarte”;
- în cazul plăgilor contuze sau cu lambouri se drenează plaga;
- tipuri de suturi: fire izolate, fire în "X", "U", Blair- Donatti, sutura continuă



■ profilaxia antitetanică

- se practică în toate plăgile suspecte de contaminare cu *Clostridium tetani*;
- plăgi cu risc: plăgi murdare cu corpi străini, prin armă de foc, arsuri sau degerături, explozie, plăgi mușcate în care există salivă, plăgi contaminate cu excremente, plăgi cu țesuturi devitalizate, mai vechi de 6 ore de la producerea lor;
- se administrează în urgență *i.m.* 1 DOZĂ = 0.5 ml ATPA (anatoxina tetanică purificată și absorbită pe fosfat de aluminiu).

■ antibioterapia

- înainte de administrarea primei doze de antibiotic se recoltează probe din produsele biologice infectate, se efectuează culturi și antibiogramme;
- se inițiază antibioterapie cu un antibiotic sau asociere de antibiotice cu spectru larg care să aibă acțiune pe stafilococi, bacili gram negativi, aerobi sau anaerobi și enterococci;
- se administrează ritmic pentru menținerea unor concentrații bactericide în organe și sânge;
- în funcție de răspunsul terapeutic, rezultatul culturii și antibiogramă se decide continuarea antibioterapiei inițiate, schimbarea sau asocierea de antibiotice cu spectru microbian diferit;
- **NU** se vor administra doua antibiotice cu același spectru de acțiune, un bacteriostatic cu un bactericid, două antibiotice cu efect toxic.

■ pansamentul plăgilor

- condițiile unui bun pansament:

- să fie făcut în condiții aseptice;
- să fie absorbant;
- să fie protector;
- să fie schimbat la timp.

■ scoaterea firelor

- firele se scot după 5 – 10 zile de la realizarea suturii, când are loc vindecarea plăgii;
- durata de timp este în raport cu:
- localizarea (ex. la față – 5 zile, mână – 10 zile);
- dimensiunea plăgii saturate (ex. laparatomie – 10 zile, incizie inghinală – 5 zile);
- complexitatea plăgii (se țin mai mult la plagile complexe);
- tensiunea la locul de sutură.
- tehnica:
 - se aseptizează plaga;
 - se prinde unul din capetele firului cu pensa și prin tracțiune ușoară se expune un segment al acestuia, situat sub nod, intrategumentar și se secționează cu foarfeca sau lama de bisturiu;
- plaga se pansează pentru încă 24 de ore.

PANSAMENTUL

- **Tehnica efectuării unui pansament** → mai mulți timpi:
 1. pregătirea medicului pentru pansament (mănuși sterile, servite de către asistentă cu instrumentele necesare);
 2. dezlipirea vechiului pansament, îndepărtarea vechiului pansament (cu blândețe, eventual după umezire respectiv cu apă oxigenată sau permanganat de potasiu);
 3. curățirea tegumentelor din jurul plăgii, centrifug;
 4. dezinfectarea pielii din jur cu alcool sau tinctură de iod;

■ 5. tratamentul plăgii → în funcție de natura sa și momentul evoluției:

- plăgi operatorii cu evoluție aseptică: nu necesită tratament special, în afară de scoaterea tuburilor de dren, a firelor sau agrafelor;
- plăgi secretante: necesită curățire (spălare cu jet de soluție antiseptică, excizie a țesuturilor mortificate),
- evacuarea colecțiilor (seroame, hematoame): scoatere a 1-2 fire de ață, înțeparea cicatricei cu un stilet butonat;
- colecții purulente: deschidere largă, drenare cu tuburi;
- plăgi accidentale: curățare de resturi vestimentare sau telurice, debridare, regularizare, lavaj antiseptic, eventual suturare;

■ 6. protecția plăgii:

- stratul de comprese trebuie să depășească marginile plăgii, iar grosimea sa nu fie mai mare de 1-2 comprese (pentru a realiza o bună capilaritate);

■ 7. fixarea pansamentului:

- galifix,
- leucoplast,
- feși.

Tipuri de pansamente:

1. pansament protector: pe plăgi care nu secretă și nu sunt drenate;
2. pansament absorbant: pe plăgi drenate sau secretante;
3. pansament compresiv: pe plăgi sângerânde (scop hemostatic), pentru imobilizarea unei regiuni, pentru reducerea unei cavități superficiale după punționare; se realizează fixare cu feși în cadrul unui bandaj;
4. pansament ocluziv: pentru plăgi însoțite de leziuni osoase (acoperirea plăgii cu comprese și vată, peste care se aplică un aparat gipsat).
5. pansament umed (priessnitz alcoolizat, cloraminat, etc.).

BANDAJE:

Fașa = banda de tifon, pânza sau țesatura elastică, de lățime și lungime diferită în funcție de regiunea pe care o acoperă și întinderea pansamentului; în general, lățimea unei feși trebuie să fie aproximativ egală cu diametrul regiunii pe care o înfașă (5-20 cm).

■ Indicații:

- fixarea pansamentului în regiuni în care substanțele adezive nu își ating scopul (extremități, regiune cefalică, plăgi periarticulare);
- fixarea pansamentelor unor plăgi situate în regiuni supuse traumatismelor în timpul activității (mână, picior);
- efectuarea unui pansament compresiv;
- imobilizare temporară a unor traumatisme ale membrelor (entorse, luxații, fracturi).

■ Principii:

- punctul de plecare și de terminare trebuie să fie la distanță de plagă;
- la membre, înfașarea se începe de obicei de la extremitate spre rădăcină (în sensul circulației de întoarcere); distal (mână, picior) se începe dinspre proximal spre distal (prin benzi de fixare);
- să acopere în întregime pansamentul;
- să fie elastică (să nu jeneze circulația) → pe traiectul vaselor mari se așează peste un strat de vată;
- să nu producă dureri (pretejarea zonelor iritate și a nervilor → să nu fie comprimate exagerat);
- să permită mișcările articulațiilor peste care trece.